

가상 건강검진 결과지

Health Check Summary

수검자 정보

성명: 오성민 성별/생년월일: 남 / 1968.06.02 나이: 만 58세
기저질환: 고혈압, 당뇨병, 수면무호흡, 심근경색 병력 검진일: 2026.07.09 문서번호: VHC-20260709-OSM-010

혈압 144/94 mmHg 고혈압 관리 필요	혈당 134 mg/dL 당뇨 관리 필요	BMI 31.8 비만 1단계
체지방률 36.1 % 높음	골격근량 25 kg 낮음 / 근감소 위험	심박 61 bpm 정상 안정시 심박

측정 항목별 판정

항목	측정값	판정	의미 및 확인사항
심박	61 bpm	정상	안정시 심박은 정상 범위로 추정
혈당	134 mg/dL	관리 필요	당뇨병 병력 및 혈당 상승으로 혈당 조절상태 확인 필요
혈압	144/94 mmHg	고혈압 조절 미흡	수축기/이완기 혈압 모두 높아 반복 측정 및 약물 조정 상담 필요
몸무게	92 kg	주의	BMI 및 체지방률이 높아 체중 감량 필요
BMI	31.8	비만 1단계	고도비만 경계 수준으로 심혈관·대사질환 위험 관리 필요
골격근량	25 kg	낮음	체중 대비 근육량 유지와 유산소·근력운동 병행 필요
체지방률	36.1 %	높음	비만 및 당뇨병과 연관된 대사위험 관리 필요

종합 판정

심박 61 bpm은 안정시 정상 범위로 추정되나, 혈압 144/94 mmHg로 고혈압 조절 미흡이 의심되고 혈당 134 mg/dL은 당뇨병 병력과 함께 혈당 관리가 필요한 수치입니다. BMI 31.8 및 체지방률 36.1%로 비만 소견이 있으며, 수면무호흡과 심근경색 병력이 있어 심혈관 위험요인에 대한 적극적인 추적관리가 필요합니다. 골격근량 25 kg은 절대량은 유지되어 있으나 체중 대비 근육량과 체지방 비율을 함께 개선하는 계획이 필요합니다.

진단 요약

구분	가상 진단명	근거	관리 수준
1	고혈압 조절 미흡 의심	혈압 144/94 mmHg, 고혈압 병력	진료 권고
2	비만 1단계 및 체지방 과다	BMI 31.8, 체지방률 36.1%	적극 관리
3	체중 대비 근육량 관리 필요	골격근량 25 kg, 체중 92 kg	운동 처방
4	심근경색 병력에 따른 심혈관 고위험군	기저질환 태고 심근경색	정기 추적

의사 소견 - 가상

- 현재 수치만으로 급성 이상을 단정할 수는 없으나, 심근경색 병력이 있는 고혈압 환자로 분류되며 혈압 144/94 mmHg는 조절 미흡 가능성이 있어 약물 복용 상태와 생활요인을 확인해야 합니다.
- 혈당 134 mg/dL은 당뇨병 병력과 함께 관리가 필요한 수치이므로 HbA1c, 공복혈당, 식후혈당 기록을 확인하고 식사·운동·약물 조정 상담이 필요합니다.
- BMI와 체지방률이 높고 수면무호흡 병력이 있어 체중 감량은 혈압, 혈당, 수면의 질 개선에 도움이 될 수 있습니다.
- 심근경색 병력자는 흉통, 호흡곤란, 식은땀, 갑작스러운 피로감이 발생하면 즉시 진료 또는 응급평가가 필요합니다.
- 수면무호흡이 있는 경우 코골이, 주간졸림, 야간호흡중단 여부를 재평가하고 필요 시 수면클리닉 추적 및 양압기 순응도 확인이 필요합니다.

권고 검사 및 추적관리

항목	권고 내용
혈압/심혈관	가정혈압 기록, 심전도, 지질검사, 심장내과 추적진료 권고
대사질환	HbA1c, 공복/식후혈당, 지질검사, 간기능, 신장기능, 요단백/미세알부민 검사 고려
근감소/관절	체성분 추적, 운동부하 평가, 수면무호흡 평가 및 운동처방 상담
생활습관	저염식, 체중감량, 금연, 절주, 수면관리, 약물 복용 순응도 확인

중요 안내

아래 처방은 데이터 기반 시뮬레이션을 위한 가상 예시입니다. 실제 복용, 조제, 보험청구, 의료기관 제출에 사용할 수 없습니다. 실제 약물은 의사의 진료와 검사 결과에 따라 결정되어야 합니다.

수진자 및 처방 정보

성명	오성민	성별/생년월일	남 / 1968.06.02
처방일	2026.07.09	진단 참고	고혈압, 당뇨병, 비만, 수면무호흡, 심근경색 병력
의료기관	헬스업 가상의원	담당의	AI 가상 주치의

가상 처방 내역

분류	가상 처방 예시	용법	기간	비고
고혈압 관리	기존 혈압약 복용 여부 확인 및 조절 상담	의사 판단	2-4주	가정혈압 기록 지참
심혈관 병력	당뇨병 약물 복용 여부 및 혈당 조절 상담	의사 판단	상시	HbA1c 결과에 따라 조정
관절 통증	심혈관 병력 약물 복용 여부 확인	의사 판단	필요 시	심장내과 처방 확인 필요
체중/근감소	영양상담, 체중감량, 수면무호흡 관리	매일/주 3-5회	12주	수면·혈압·혈당 기록 병행

생활 처방

영역	권고 내용
식이	하루 염분과 정제 탄수화물 섭취를 줄이고, 단백질·채소 중심 식사와 규칙적인 식사시간을 권고합니다.
운동	빠른 걷기, 실내자전거 등 유산소 운동과 대근육 중심 근력운동을 병행하되 흉통·호흡곤란 시 즉시 중단합니다.
혈압관리	아침/저녁 안정 후 혈압과 혈당을 측정하여 기록하고, 상승이 반복되면 진료를 받습니다.
심혈관 주의	흉통, 호흡곤란, 식은땀, 왼팔·턱 통증 등 증상이 있으면 즉시 응급평가가 필요합니다.